

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIR LEBEN WERTSCHÄTZUNG	Verfahrensanleitung „Umgang mit Betäubungsmitteln(BTM) “	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

1. Ziel und Zweck:

- Betäubungsmittel werden sicher verwahrt. Jeder Zugriff durch unautorisierte Dritte ist unterbunden.
- Der tatsächliche Bestand an Betäubungsmitteln entspricht jederzeit den Angaben im Betäubungsmittelbuch.
- Die tägliche Arbeit der Pflegekräfte wird durch die Sicherheitsmaßnahmen nicht unnötig beeinträchtigt.

2. Anwendungsbereich:

- Als Betäubungsmittel (BTM) werden Substanzen bezeichnet, die massiv die Bewusstseinslage oder die Stimmung manipulieren können. Hervorrufen können sie Zustände wie etwa Euphorie, Halluzinationen, Selbstüberschätzung oder panische Reaktionen. Da Betäubungsmittel psychisch oder physisch abhängig machen können, ist ihre Nutzung nur in Ausnahmefällen und dann unter strikten Auflagen erlaubt.
- Im Betäubungsmittelgesetz (BtMG) sind alle Substanzen aufgelistet, die zu den Betäubungsmitteln zählen. Das Gesetz regelt den Umgang mit Betäubungsmitteln und stellt deren Missbrauch unter Strafe. Es legt fest, unter welchen Bedingungen Betäubungsmittel verschrieben, beschafft, genutzt und ggf. vernichtet werden.
- Betäubungsmittel dürfen nur dann appliziert werden, wenn andere Präparate, die nicht zu dieser Stoffgruppe zählen, keine hinreichende Wirkung zeigen.
- In unserer Einrichtung werden Betäubungsmittel hauptsächlich im Rahmen der Schmerztherapie genutzt.

3. Durchführung und Zuständigkeiten

Betäubungsmittelschrank:

- Wir halten in jedem Wohnbereich einen einbruchssicheren Betäubungsmittelschrank bereit. Dieser entspricht i. d. R. der Norm EN 1143-1, Widerstandsgrad 1.
- Der Schrank darf ausschließlich für das Einlagern oder für die Entnahme von Medikamenten geöffnet werden. Danach ist er unverzüglich wieder zu verschließen.
- Aus dem Betäubungsmittelschrank wird stets nur das benötigte Medikament und niemals mehr als die erforderliche Menge entnommen. Ausgenommen von der Lagerungspflicht sind Betäubungsmittelmengen, die höchstens den durchschnittlichen Tagesbedarf einer Teileinheit darstellen und ständig griffbereit sein müssen. Diese sind so zu sichern, dass eine schnelle Entwendung wesentlich erschwert wird.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	1	Verw./MA

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIR LEBEN WEITSCHÄTZUNG	Verfahrensanleitung „Umgang mit Betäubungsmitteln(BTM) “	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

- Die Heimleitung und die Pflegedienstleitung sind für die Sicherung des Betäubungsmittelschranks verantwortlich. Sie können diese Aufgabe aber an die Schichtleitungen delegieren.
- Der Schlüssel wird von der jeweiligen Schichtleitung verwahrt und bei Schichtwechsel der nächsten Schichtleitung persönlich übergeben. Die Schlüssel sind von den dazu berechtigten Pflegekräften grundsätzlich in persönlichen Gewahrsam zu nehmen. In keinem Fall wird der Schlüssel unbewacht gelagert.

Betäubungsmittelheft:

- Über den Bestand und über den Verbleib von Betäubungsmitteln wird ein Betäubungsmittelblatt 3313 geführt. Dieses ist in der Patientenakte hinterlegt. Die Seiten des Betäubungsmittelhefts sind fortlaufend nummeriert.
- Alle Änderungen im Bestand werden sofort aktualisiert, etwa bei einer Lieferung neuer Betäubungsmittel durch die Apotheke oder bei einer Abgabe an den Patienten.
- Wir vermerken das Datum, den vollständigen Namen des Patienten sowie die Art und die Menge des Betäubungsmittels. Dokumentiert wird auch der Name und Anschrift des verordnenden Arztes sowie der Name der Pflegekraft, die das Betäubungsmittel aus dem Schrank entnimmt oder dort einlagert.
- Im Betäubungsmittelheft wird auch vermerkt, wenn nur eine Teilmenge des entnommenen Betäubungsmittels appliziert wird und ein Teil verworfen werden muss; etwa bei Ampullen.
- Ändert sich die Verordnung egal in welcher Art und Weise, wird ein neues fortlaufendes Blatt angelegt
- Alle Vorgaben zur dokumentenechten Dokumentation müssen beim Führen des Betäubungsmittelheft besonders strikt umgesetzt werden. Bei Schreibfehlern wird das falsch geschriebene Wort nur einmal durchgestrichen, ohne es unleserlich zu machen. Zu unterlassen sind Korrekturen, die das Geschriebene unkenntlich machen, etwa durch den Einsatz von Tipp-Ex.
- Betäubungsmittelnachweise müssen drei Jahre nach der letzten Eintragung aufbewahrt werden.
- Einmal im Monat gleicht die Pflegedienstleitung den Bestand an Betäubungsmitteln mit den Angaben im Betäubungsmittelheft ab. Die Überprüfung wird durch eine Unterschrift dokumentiert.

Eingangskontrolle:

Bei allen Neuzugängen von Betäubungsmitteln erfolgt eine Wareneingangskontrolle. Diese umfasst die Prüfung der eingehenden Medikamente z. B. auf Unversehrtheit, Verfallsdatum und Übereinstimmung mit der Verschreibung.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	2	Verw./MA

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIR LEBEN WERTSCHÄTZUNG	Verfahrensanleitung „Umgang mit Betäubungsmitteln(BTM) “	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

Medikamentengabe:

- Nur Pflegefachkräfte dürfen Betäubungsmittel verabreichen.
- Wir stellen sicher, dass der Patient das Medikament tatsächlich korrekt und unverzüglich einnimmt. Ein Horten von Betäubungsmitteln muss vermieden werden. Überdies besteht die Gefahr, dass nicht sofort eingenommene Medikamente in die Hände von Dritten gelangen; etwa von Kindern bei einem Familienbesuch.

Verlust und Weitergabe von Betäubungsmitteln:

- Wenn eine Ampulle zu Bruch geht, ruft die Pflegekraft umgehend Zeugen hinzu. Diese machen sich ein eigenes Bild vom Schaden. Der Verlust wird umgehend im Betäubungsmittelheft protokolliert und das Dokument von allen Beteiligten unterschrieben.
- Wenn es Hinweise auf einen Diebstahl gibt, wird unverzüglich die Pflegedienstleitung informiert. Danach wird der Bestand im Betäubungsmittelschrank sorgfältig mit dem Betäubungsmittelblatt abgeglichen. Wird der Verdacht nicht vollständig ausgeräumt, muss die Polizei informiert werden.
- Abgelaufene und unbrauchbar gewordene Betäubungsmittel werden an die Apotheke zurückgegeben. Hier erfolgt vorab ein Fax an die Apotheke damit die Abholung organisiert werden kann. Bei Abholung wird dann nochmals von der Apotheke unterschrieben. Ganz ähnlich verfahren wir, wenn ein Patient verstirbt und noch Restbestände an Betäubungsmitteln vorhanden sind. Wir erhalten von der Apotheke einen "Vernichtungsnachweis", der dem BTM-Nachweis angefügt wird. Aus dem Nachweis geht hervor:
 - Bezeichnung, Stückelung und Gesamtmenge des Medikaments
 - der Name des Bewohners
 - der verordnende Arzt
 - die abgebende Pflegeeinrichtung
 - ein Stempel und die Unterschrift der Apotheke
- Betäubungsmittel werden (bis auf wenige rechtliche Ausnahmen) nicht für andere Patient weiterverwendet. Auch an die Familienangehörigen eines verstorbenen Patient werden keine Betäubungsmittel ausgehändigt.
- Betäubungsmittel dürfen nur für den jeweiligen Patient verwendet werden. Sie dürfen also auch nicht an andere Stationen mit der Absicht "ausgeliehen" werden, diese mit späteren Betäubungsmittellieferungen wieder auszugleichen.
- Es darf kein "Übervorrat" gebildet werden, also ein Vorrat von Betäubungsmitteln, die keinem Patienten mehr zugeordnet werden können.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	3	Verw./MA

	Verfahrensanleitung „Umgang mit Betäubungsmitteln(BTM) “	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

Diese Medikamente dürfen niemals als "Notfall-" oder "Akutmedikamente" verwendet werden. Sie werden stattdessen entsorgt.

Qualifikation/Durchführungsverantwortung:

- Pflegefachkräfte

Prozessverantwortlichkeit:

- Pflegedienstleitung, stellv. PDL, Teamleitung

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	4	Verw./MA